

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103059-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA JOSE DE AGUIAR

MEDIDA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETOS DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar e manteve a decisão que determinou a expedição de RPV, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5103059-07.2024.4.02.5101

510015437677 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103059-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA JOSE DE AGUIAR

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência na qual a UNIÃO objetiva atribuir efeito suspensivo a decisão proferida nos autos originários de nº **5003895-66.2024.4.02.5102** (Evento 98) pelo juízo do 6º Vara Federal de Niterói que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com vistas ao fornecimento das medicações “*BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), ALPRAZOLAM 1MG e DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®), para o período de 30 dias - EVENTO 76, ANEXO3*”.

A liminar foi indeferida (Evento 3).

A parte autora apresentou contrarrazões (evento 11).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face do Juízo Federal da 6ª Vara Federal de Niterói, em razão da decisão proferida, in verbis:

“Inicialmente, mantenho o indeferimento da tutela de urgência quanto ao medicamento QUETIAPINA, haja vista que a documentação acostada no EVENTO 34, RECEIT3, FL. 2 e 3 não alterou as conclusões do NATJUS apostas nos pareceres dos EVENTOS 8 e 19, que embasaram a decisão do EVENTO 21.

Por outro lado, a parte autora acostou aos autos a prescrição médica atualizada e três orçamentos de estabelecimentos distintos, relativos aos fármacos objeto da presente demanda, em relação aos quais foi deferida a tutela de urgência para seu fornecimento, a BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), ALPRAZOLAM 1MG e DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®), para o período de 30 dias - EVENTO 76, ANEXO3.

Frise-se que a SERTRALINA 100MG vem sendo fornecida na via administrativa pelo réu Estado do Rio de Janeiro.

Foram intimados os réus para manifestação quanto ao não fornecimento do fármaco - EVENTO 55, no entanto, observo que decorridos os prazos in albis.

Assim, defiro o pedido de penhora on line, para determinar a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com supedâneo no art. 854 do CPC, em rateio, em desfavor dos réus, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE NITERÓI, com o bloqueio da quantia de R\$ 202,33, PARA CADA RÉU, referente ao orçamento de menor valor acostado ao EVENTO 76, ANEXO 3, FL. 3.

Sendo encontrados valores, determino desde já a sua transferência via SISBAJUD para uma conta à disposição deste 6ª Vara Federal de Niterói na Caixa Econômica Federal, agência nº 0174.

Sem prejuízo da medida acima e diante da impossibilidade de bloqueio de verbas da União através da penhora on line, determino a expedição de RPV no valor total de R\$ 202,33, para aquisição do medicamento objeto desta ação, intimando-se em seguida as partes.

Efetuada o bloqueio e a transferência bancária com relação ao Estado do Rio de Janeiro e ao Município de Niterói, intime-se o autor sobre a expedição de mandado de pagamento em seu favor.

Com a informação da juntada do demonstrativo da RPV aos autos, intime-se o autor para ciência.

Tão logo o autor adquira os medicamentos, deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos nota fiscal discriminada, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal.

Consigna-se que os valores disponibilizados são suficientes para 3 (três) meses de tratamento.

Tudo cumprido, intinem-se os réus para se manifestarem acerca do requerimento de inclusão dos medicamentos ROSUVASTATINA 10mg c/ 30 cp (1 caixa) e COLÍRIO LUBRIFICANTE SYSTANE COMPLETE 10 ML (1 caixa), pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 329, II do CPC.

Ao final, voltem conclusos."

Aduziu que o Magistrado do Juizado Especial Federal determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado e que a expedição deliberada de RPV antes do trânsito em julgado representa flagrante violação à ordem legal e constitucional de pagamentos. Requereu a concessão da segurança para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado.

É o breve relato.

Observa-se que a determinação de expedição de RPV em face da União adveio do descumprimento da decisão proferida no Evento 21 do processo originário nº 5003895-66.2024.4.02.5102, *ipsis litteris*:

"A parte autora, devidamente qualificada na inicial, propõe a presente demanda em face da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Niterói, objetivando que lhe sejam fornecidos os medicamentos, abaixo descritos, e conforme prescrição médica acostada ao EVENTO 1, ANEXO 2

a) BETAISTINA 24 MG (2 caixas);

b) MECLIZINA (MECLIN®) 25MG (6 caixas);

c) SERTRALINA 200MG/DIA (2 caixas);

d) QUETIAPINA 25MG (1 caixa);

e) METROPOLOL (SELOZOK®) 50MG (1 caixa);

f) ALPRAZOLAM 1MG (1 caixa);

g) DEXPANTENOL 50MG/G GEL OFTALMICO 10ML (EPITHELIZE®) (1 caixa)

Na peça inaugural aduz que é diagnosticada com TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84); TRANSTORNO COGNITIVO LEVE (CID 10 F06.7); TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO (CID 10 F41.2); SÍNDROME DO CÓLON IRRITÁVEL (CID 10 K58); DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO (CID 10 K21); HEMORRÓIDAS (CID 10 I84); TRANSTORNOS DA FUNÇÃO VESTIBULAR (CID 10 H81); OUTROS DESLOCAMENTOS DISCAIS INTERVERTEBRAIS ESPECIFICADOS (CID 10 M51.2); OUTRA OSTEOMIELITE CRÔNICA HEMATOGÊNICA (CID 10 M86.5); OUTROS TRANSTORNOS DA RÓTULA (CID 10 M22.8) e OUTROS TRANSTORNOS FUNCIONAIS DO INTESTINO (CID 10 K59), razão pela qual necessita dos medicamentos e insumos acima descritos.

Informa, ainda, que não possui recursos financeiros para adquirir todos os medicamentos em questão.

Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, há que se avaliar a presença de elementos que evidenciem: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, que deve prestá-la integralmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No bojo da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o Min. Gilmar Mendes delineou critérios que devem orientar as decisões judiciais, de modo que não haja indevida interferência nas políticas públicas a cargo do Poder Executivo e nem prejuízo ao direito à saúde.

Uma das diretrizes estabelecidas pelo i. Min. foi que "em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial" (STF, STA nº 175, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 17.03.2010).

Conclui-se que, nos casos em que há tratamento fornecido pelo SUS, a parte autora somente faz jus à medicação diversa caso haja comprovação de que, por especificidades de seu organismo, a medicação fornecida não é eficaz.

Nesse sentido, é imperioso destacar tese fixada no julgamento de recurso repetitivo sobre o tema pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.657.156 - Tema 106), segundo a qual para fornecimento de medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Quanto à análise do parecer do NatJus (EVENTOS 10 e 25), em resumo, restou concluído o que segue:

a) Os medicamentos BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), SERTRALINA e ALPRAZOLAM 1MG estão indicados em bula ao tratamento do quadro clínico da Autora conforme consta em relato médico (Evento 1, ANEXO6, Páginas 13 a 15), porém, não integram nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro; especificamente no caso dos dos três primeiros, não há menção à existência de substituto terapêutico no âmbito do SUS;

b) o médico assistente, com relação ao fármaco APRAZOLAM 1MG informa a impossibilidade de substituição pelos fármacos fornecidos pelo SUS, no caso Clonazepam 2,5mg/ml e diazepam 5mg e 10mg (EVENTO 8, PARECER1, III - CONCLUSÃO, ITEM 16 e EVENTO 12, ANEXO2, FLS. 1/2)

c) o medicamento QUETIAPINA não apresenta indicação descrita em bula para o tratamento do transtorno do espectro autista, nem mesmo para uso off label pelo órgão responsável, e, na forma da Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022, exige-se a recomendação pela Conitec, com demonstração de evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e padronização no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, de forma a autorizar o uso off-label de medicamento em indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa (EVENTO 8, PARECER1, III - CONCLUSÃO, ITEM 8), o que, por todo exposto, não ocorre; porém, o médico assistente esclarece sua necessidade, face a impossibilidade de troca pelo substituto terapêutico, no caso, pelo fármaco Risperidona (EVENTO 12, ANEXO2, FLS. 1/2), justificando, para seu uso, "que diversas comorbidades psiquiátricas podem coexistir no TEA" e que "A quetiapina é classificada como antipsicótico atípico de segunda geração com evidências consistentes de eficácia em transtorno depressivo, se associada a antidepressivo; e evidências incompletas de eficácia em transtorno de ansiedade generalizada refratário";

d) a QUETIAPINA 50MG é disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); porém, as doenças que acometem a Demandante - não estão dentre as contempladas para a retirada do medicamento pela via do CEAF, impossibilitando a obtenção do fármaco pela via administrativa;

e) a SERTRALINA 200MG não está disponível no REMUME-NITERÓI, que somente fornece a dosagem de 25MG ((EVENTO 8, PARECER1, III - CONCLUSÃO, ITEM 10);

f) e, após a juntada de laudo oftalmológico, no EVENTO 12, ANEXO2, FLS. 4/5, verificou-se que o DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®) está indicado para a condição clínica da Autora; contudo, não integra nenhuma lista oficial de medicamentos do SUS; e

g) Quanto à indicação do pleito METOPROLOL (SELOZOK®), os laudos médicos restaram silentes quanto à descrição do quadro clínico da autora e acerca das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS do medicamento metoprolol 50mg (Atenolol 50mg, carvedilol 3,125mg e 12,5mg e propranolol 40mg); entretanto, conforme documento da Defensoria Pública (Evento 13, PET1, Página 1), consta que a autora conseguiu se consultar com cardiologista, tendo a dose do metoprolol (Selozok®) reduzida de 50mg para 25mg e obteve o medicamento supracitado na farmácia popular (EVENTO 19, PARECER1, III-CONCLUSÃO, ITENS 4 e 5).

Partindo da premissa jurisprudencial, no caso em apreço, segundo parecer do NAT juntados nos EVENTO 8 e 19, verifica-se que todas as medicações acima descritas são indicadas em bula para o tratamento da patologia da autora - exceto o HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA -, e que algumas (itens "a" e "f") sequer integram lista oficial de medicamentos a serem dispensados pelo SUS.

Contudo, conforme já esclarecido no item "c" acima, especificamente no caso do medicamento QUETIAPINA 25MG, verifica-se que não está indicado ao quadro clínico da autora nem por bula, nem autorizado seu uso off label excepcionalmente pela ANVISA, ou mesmo pela CONITEC, nos termos da Lei nº 14.313/2022.

Já com relação ao medicamento METOPROLOL (SELOZOK®), verifica-se a ausência de descrição do quadro clínico da autora e sua disponibilidade pelo Programa de Farmácia Popular, inclusive já tendo sido adquirido pela autora através de tal meio.

Assim, desde logo, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA com relação aos fármacos QUETIAPINA 25MG e METOPROLOL (SELOZOK®), pelas razões anteriormente expostas.

Ressalto que, em havendo alterações quanto à indicação dos fármacos ao quadro clínico da autora, especialmente do HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA, o pleito da tutela antecipada poderá ser revisto.

Por outro lado, restou demonstrada a necessidade dos medicamentos e a impossibilidade ou mesmo inexistência de substitutos terapêuticos em relação aos fármacos: BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), SERTRALINA , ALPRAZOLAM 1MG e DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®).

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação é evidente, visto que há grave risco de piora no tratamento do autor se o medicamento não for ministrado para controle de seu quadro clínico, ressaltando-se também que o artigo 5º, caput da Constituição Federal assegura a todos o direito à vida.

Em observância ao que foi decidido pelo STF, no Tema 793, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, incumbirá à União Federal dar cumprimento ao decisor, por não integrarem nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação pelo SUS da BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), SERTRALINA , ALPRAZOLAM 1MG e DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®), sem prejuízo de posterior ressarcimento das despesas pelos outros entes públicos envolvidos, na fase de cumprimento do julgado.

Isto posto, concedo em parte a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar à União Federal, o fornecimento dos fármacos BETAISTINA 24MG, MECLIZINA 25 MG (MECLIN®), SERTRALINA , ALPRAZOLAM 1MG e DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO 50 MG/G (EPITHELIZE®), segundo prescrições médicas acostadas ao EVENTO 1, ANEXO 6, FL. 15 e EVENTO 12, ANEXO2, FLS. 4/5 na quantidade necessária para uso mensal

Citem-se os réus e intime-se a UNIÃO FEDERAL, para cumprimento da presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determino desde logo que a parte autora apresente nova prescrição médica para cada um dos medicamentos pleiteados e 3 (três) orçamentos a serem obtidos em 3 (três) estabelecimentos comerciais distintos, no prazo de 5 (cinco) dias."

Sobre o tema debatido, propriamente dito, destaca-se a tese fixada, em sede de recurso repetitivo, que permite a efetivação de sequestro de recursos, via bloqueio de recursos, em hipótese de desídia do Ente Público, no cumprimento de demanda de direito à saúde:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de

valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Transcreve-se, ainda, trecho do voto do Relator:

"4. Dessa forma, é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida da parte demandante.

5. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima.

6. Frise-se, ainda que, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.09.2008).

7. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde da demandante com o fornecimento dos medicamentos adequados, em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo."

No caso, o órgão julgador verificou que não houve o cumprimento da decisão pela União, determinando a intimação da mesma para manifestação sobre as providências pertinentes.

Até a presente data não há informação sobre o cumprimento de tutela pelos réus.

Seria tudo muito mais fácil, é verdade, que a União fornecesse um número de conta bancária para bloqueio, como faz o Estado do Rio de Janeiro e o Município, quando se faz necessário, para uso do sistema BACENJUD, mas isso não é possível, quando se trata da União, cuja conta não é bloqueável, como determinam os enunciados das Jornadas de Saúde, ao estabelecer as prioridades de forma de execução.

Se isso fosse feito, não seria expedido RPV.

Sendo assim, por ora, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que determinou a expedição de RPV.

Intime-se a parte autora para apresentação de contrarrazões.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar e manteve a decisão que determinou a expedição de RPV.